

INDICADO POR: Instagram☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

NICOLAS PEDROSO LIMAIDADE: 25 PESO: 87 ALTURA: 1,67 PROFISSÃO: Programador Home office

SINTOMAS:

QUEIXAS: Acorda cansado; Poco; sonolência diurna; ↓ concentração.MEDICAMENTOS: tomava vitamina;MÉDICO: Dr. Flávio Panarelli.

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: Ø

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 00h 00h30' HORA QUE ACORDA: 7h30'COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: ☒ S () N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: () S ☒ N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: ☒ S () NBEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N FDS.FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: 1x (3x semana)

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 16,5 e 1h SPO2: 87% PSG em 2023PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Enxaqueca; Rinite; TDAH
infância.CIRURGIAS: (N) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA Desvio septo ã cirúrgico

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

Admissão 21/02/2025Auto 4 a 10 cmH₂O↑ Peso há 2 anos - 12 Kg.max Dream Wear (M)28/02/25P= 5,5 cmH₂OPSY: 9,2 cmH₂OIAH= 4,2 e 1hmano= 5h20minfuga= 101min.↓ P= 5 a 9 cmH₂OSilvia07/03/25P= 6,2 cmH₂OIAH= 2,9 e 1hmano= 6h40minfuga= ØFixo Pressão: 6,2 cmH₂O↑ sempre 5 cmH₂OSilvia

13/03
25

$P = 6,2 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 6,3 \text{ e/h}$

mdevo: 1h 25'

fuga: 10,2 l/m (perc)

$\uparrow P = 6,6 \text{ cm H}_2\text{O}$

Pte relata estar
dormindo no sofá devido
ao calor

Natacha

04/04 / 25

$P = 7 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 6,2 \text{ e/h}$

mdevo: 3h 55'

fuga: 16,9 l/m

Ainda a dificuldade
de colocar todos os dias

Natacha

Nome: NICOLAS PEDROSO LIMA
Data de Nascimento: 26-3-1999
IMC: 26,89
Sexo: Masculino
Data do exame: 25-04-2023

Peso: 75 kg
Altura: 1,67 m
Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO
PASSARELLI PRADO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 25-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 485,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 25,0 e 115,0 minutos. O tempo total de sono foi de 435,5 min, eficiência de 89,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 59,4%; estágio N3: 17,2%; sono REM: 20,9%. O índice de despertares foi de 14,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 16,5/hora, sendo 1 obstrutiva, 0 mistas e 0 centrais e 118 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 87%, permanecendo 0,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 104 bpm e NREM de 47 - 106 bpm.

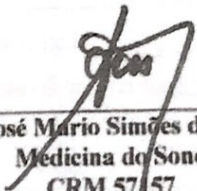
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 16,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (11,8/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157